التقييم المستقل لبرنامج الصحة المجتمعية 2021–2023

إعداد: مركز تل الورد للبحوث والتقييم — حزيران/يونيو 2024

أُعدّ لصالح مؤسسة الريحان للتنمية

> وثيقة مُصطنعة لأغراض العرض والاختبار؛ جميع الأسماء والأرقام والجهات الواردة فيها خيالية.

البيان	التفاصيل
الفترة التي يغطيها التقييم	كانون الثاني/يناير 2021 – كانون الأول/ديسمبر 2023
منطقة البرنامج	سهول النخيل وأطراف الهضبة الشرقية
المشاريع المشمولة	CHP-2021-01 والأنشطة الممولة من الموارد الذاتية
فترة العمل الميداني	12 شباط/فبراير – 18 نيسان/أبريل 2024
فريق التقييم	د. لينا العمري وم. هشام القدسي (أسماء مستعارة)

الغرض من التقييم

كلّفت المؤسسة المركز بتقييم البرنامج بعد ثلاث سنوات من التوسع الذي أعقب الجائحة. ويغطي التقييم الفعالية والكفاءة والاستدامة، ويقارن مؤشرات صحة الأم والطفل بنتائج المسح الصحي للأسر الذي أجراه البرنامج في عام 2021.

الملخص التنفيذي

نقيّم البرنامج بأنه **ناجح بدرجة جيدة.** فقد توسع بسرعة دون أن يفقد صلته بالمجتمعات، وتحسنت أغلب المؤشرات الصحية التي يستهدفها.

أبرز النتائج

- قدمت العيادات المتنقلة خلال السنوات الثلاث 78,350 استشارة طبية، وتضاعف عدد الاستشارات السنوية تقريباً بين 2021 و2023.
- ارتفع عدد العيادات المتنقلة من 4 إلى 6، وعدد متطوعي الصحة المجتمعية من 46 إلى 76.
- ارتفعت نسبة الأطفال بعمر 12–23 شهراً الذين تلقوا جميع اللقاحات الأساسية إلى 89% في المسح الختامي.
- بلغت كلفة الاستشارة الطبية الواحدة في المتوسط 27.6 دولاراً أمريكياً، شاملة الأدوية والنقل والرواتب.
- خفف توفير الأدوية الأساسية مجاناً منذ 2022 جزءاً ملموساً من الإنفاق الصحي على الأسر الأشد فقراً.

أبرز التحديات

- الاعتماد الكبير على مانح رئيسي واحد لتشغيل العيادتين المضافتين.
- ضعف الإحالة من العيادات المتنقلة إلى المستشفى في الحالات الطارئة ليلاً.

المنهجية

- **المسح الختامي للأسر:** كرر الفريق المسح الصحي للأسر لعام 2021 في التجمعات الاثني عشر نفسها، على عينة من 1,500 أسرة سُحبت بالطريقة العنقودية ذاتها.
- **مراجعة السجلات:** شملت سجلات الاستشارات اليومية في العيادات الست، وسجلات متطوعي الصحة المجتمعية، والتقارير المالية للبرنامج.
- **مقابلات:** أُجريت 22 مقابلة مع أطباء العيادات وممرضيها، وموظفي مديرية الصحة، وأعضاء مجالس محلية.
- **مجموعات نقاش:** نُظمت 10 مجموعات نقاش مع الأمهات ومتطوعي الصحة المجتمعية وكبار السن.

حدود التقييم

لا يتيح تصميم التقييم نسبة كل التحسن في المؤشرات الصحية إلى البرنامج وحده، إذ نفذت مديرية الصحة حملة تطعيم وطنية في عام 2023. كما تعتمد بعض المؤشرات على إفادة الأمهات.

مخرجات البرنامج حسب السنة

المؤشر	2021	2022	2023
العيادات المتنقلة العاملة	4	6	6
الاستشارات الطبية	21,450	26,800	30,100
المستفيدون المباشرون	12,930	15,200	17,400
متطوعو الصحة المجتمعية	46	76	76

بلغ مجموع الاستشارات خلال السنوات الثلاث 78,350 استشارة. ويعود أغلب النمو في 2022 إلى إضافة العيادتين الجديدتين، بينما يعود نمو 2023 إلى الجدول الأسبوعي الثابت الذي رفع عدد المراجعين في كل زيارة.

ولاحظ الفريق أن نحو 38% من الاستشارات تخص الأطفال دون الخامسة، و21% تخص الحوامل والمرضعات، وأن الأمراض التنفسية والإسهال أكثر أسباب المراجعة شيوعاً لدى الأطفال.

ولا تقتصر مخرجات البرنامج على الاستشارات، إذ يتولى أطباء العيادات ومتطوعو الصحة المجتمعية تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية لا تقدمها العيادات المتنقلة، كالولادات المتعسرة والكسور وسوء التغذية الحاد الشديد. وقد بلغ مجموع ما أحالته العيادات والمتطوعون خلال السنوات الثلاث إلى المستشفى الحكومي ومراكز التغذية العلاجية

1,840 حالة، تابع الفريق الطبي 72% منها حتى وصولها فعلاً إلى المنشأة المحال إليها، في حين تعذّر التحقق من وصول البقية بسبب ضعف التواصل مع المستشفى، ولا سيما في الحالات الليلية.

النتائج الصحية مقارنة بمسح 2021

المؤشر	مسح 2021	المسح الختامي 2024
الأطفال بعمر 12–23 شهراً الذين تلقوا جميع اللقاحات الأساسية	82%	89%
النساء اللواتي أجرين أربع زيارات رعاية أو أكثر خلال الحمل	57%	66%
الولادات في منشأة صحية	71%	78%
الأسر التي تعرف موعد زيارة العيادة المتنقلة	63%	88%
الأطفال المصابون بسوء تغذية حاد متوسط	6.5%	4.8%

يُعد ارتفاع معرفة الأسر بمواعيد العيادات أوضح أثر مباشر للبرنامج، وهو نتيجة الجدول الثابت والرسائل النصية. أما تحسن التطعيم فيعود جزئياً إلى الحملة الوطنية.

الكفاءة والاستدامة والتوصيات

بلغ إنفاق البرنامج 2,160,000 دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث، منها 610,000 في 2021 و720,000 في 2022 و830,000 في 2023. وبقسمة الإنفاق على عدد الاستشارات تبلغ كلفة الاستشارة الواحدة 27.6 دولاراً أمريكياً، وهي كلفة معقولة لعيادات تصل إلى تجمعات نائية.

التوصيات

1. **تنويع مصادر تمويل العيادتين المضافتين** قبل انتهاء المشروع CHP-2021-01، والتفاوض مع مديرية الصحة على تحمل جزء من رواتب الكادر الطبي.
2. **إنشاء آلية إحالة ليلية** بالتعاون مع المستشفى الحكومي وسيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني.
3. **إدماج متطوعي الصحة المجتمعية في نظام المديرية** للتبليغ عن الأمراض.
4. **مواصلة توفير الأدوية الأساسية مجاناً** للفئات الأكثر حاجة.

التقرير الكامل متاح على الرابط https://example.org/reports/chp-evaluation-2024.